



INFORME DE DIAGNÓSTICO INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : Emiliano Ortega Santana.
Fecha de Nacimiento : 06 de abril de 2019.
Edad : 6 años, 9 meses.
Nivel escolar : Primero básico.
Institución escolar : Colegio Villa España.

II. Motivo de consulta / Hipótesis Diagnostica inicial

Padres solicitan evaluación interdisciplinaria debido a las dificultades observadas en primera infancia, relacionada con dificultades para adaptarse y desafíos principalmente a nivel conductual. Existe diagnostico anterior de Mutismo Selectivo.

III. Antecedentes generales

Antecedentes adjuntos en anexo anamnesis.

IV. Procedimiento e instrumentos de de evaluación

- Observación clínica.
- Entrevista con los padres
- Autism Diagnostic Interview Revised (Entrevista semi-estructurada para el diagnóstico temprano en autismo) ADI-R.
- Módulo 3 (niños adolescentes) / ADOS-2. *Autism Diagnostic Observation Schedule, second Edition. Western Psychological Services, California, EE.UU.* Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K. y Bishop, S.L. (2015). Manual (parte I): Módulos T, 1-4 (T.Luque, adaptadora). Madrid: TEA Ediciones.
- Observación clínica estructurada del procesamiento sensorial.

- Cuestionario sensorial HOGAR. SPM Sensory processing Measure-school. Cheryl Ecker and L. Diane Parham.
- Test proyectivo gráfico: La Familia. Louis Corman.
- Test de selectividad alimentaria en niños. Psicoeduka.

V. Análisis de resultados

1. Comportamiento observado

Emiliano se presenta con vestimenta y apariencia acorde a su edad e ingresa de forma autónoma a la sala. Se aprecia bastante observador con los materiales dispuestos en sala, mostrando mayor interés por los juegos, tendiendo a presentar conductas desafiantes cuando se le solicitan actividades que no están dentro de su foco de interés. Asimismo, tiende a mostrar oposición al establecimiento de límites, sin embargo, mediante negociaciones logra ceder y realizar las actividades propuestas.

Por otro lado, Emiliano tiende a prestar atención cuando específicamente le dicen su nombre, de lo contrario, pierde el foco de atención enfocándose solo en su área de interés.

Ámbito cognitivo y conductual

Emiliano se presenta como un niño amable y con motivación para realizar actividades de su interés, lo que demuestra patrones restringidos de interés que se manifiestan como insistencia en realizar un tipo de juego. Ante el otorgamiento de límites o respuestas negativas a lo que él quiere hacer, se aprecian conductas desafiantes y, ante las preguntas realizadas por el test aplicado, tiende a responder con palabras sueltas, acotadas o simplemente a no responder, según el interés del momento, además de no comprender en su totalidad las preguntas planteadas.

Por otro lado, ante momentos de frustración, Emiliano presenta ciertas desregulaciones, las cuales aparecían ante la introducción de demandas, como lanzar los objetos de la mesa, gritar o querer empujar, pero que, ante negociaciones o límites marcados, logra ceder. En específico, con el test de la familia, Emiliano logra ceder luego de presentar este tipo de conductas, tratando de realizar la actividad con rapidez para seguir jugando, no obstante, dibuja a “Mickey Mouse” como parte de su familia.

Ámbito emocional

En lo que compete al ámbito emocional, se aprecia a Emiliano como un niño alegre y colaborador cuando se dispone a realizar alguna actividad o situación de interés, sin embargo, se presencia que Emiliano presenta dificultades en la identificación y expresión de sus emociones, tendiendo a reaccionar de manera más intensa o impulsiva, por lo que hay baja tolerancia a la frustración y manejo conductual, las cuales podrían aparecer para mantener una vía de escape o evitación de la demanda.

Ámbito familiar

En cuanto al área familiar, Emiliano logra reconocer la jerarquía familiar, aunque se percibe que el padre es quien tiene mayor autoridad, la madre se aprecia como la figura de contención, manteniendo buena

relación con todos los integrantes del sistema familiar, aunque escasa comunicación verbal por parte de Emiliano.

2. Valoración Cuantitativa

ADI-R: Autism Diagnostic Interview, Revised.

Resultados algoritmo diagnóstico

AREA	Puntuación	Observación
Interacción social	10/10	Cumple criterios
Comunicación (Verbal)	8/8	Cumple criterios
Conducta repetitiva	3/3	Cumple criterios
Dificultades del desarrollo	1/1	Cumple criterios

ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule. Prueba de interacción directa en la que se presentan diferentes situaciones sociales con el fin de valorar su nivel de comunicación recíproca, juego, interacción y conducta.

MODULO 3 (Fluidez verbal)		
AREA	Puntuación	
Comunicación	2	
Interacción Social Recíproca	4	
TOTAL afectación social	6	
Comportamiento restringido y repetitivo	2	
TOTAL	8	Clasificación

Corte autismo: 9 Corte espectro autismo: 7

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parkham.

Áreas	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión	42		
Audición	44		
Tacto	43		
Gusto y olfato	44		
Conciencia Corporal	40		
Equilibrio y movimiento		69	
Planificación e ideas			70
Participación social		61	

Observación estructurada del procesamiento sensorial

Sistema vestibular Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/conexiones vestibulo-cerebelosas	Sistema propioceptivo	Sistema tátil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: no fue pesquisado, Emiliano no se habituar a la prueba. 1.- Extension anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: inconsistente, existe dificultad en extensión de cuello. 2.-Reacciones de protección: Inconsistente, desafíos en lateral y anterior. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: logrado. 3.2 Anticipatorias: no logrado 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: inconsistente 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente compensa con rigidez de cuello. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bi: inconsistente. 5.2.- Lateralidad: inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: desafíos en movimientos rotatorios y lineales.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente en movimientos aislados/combinados. Talón a punta del pie: no logrado. Extensión de brazos Schiller: inconsistente, requiere de apoyo visual. 2.- Tono muscular: presente 3.-Control postural: Inconsistente, no controla musculatura abdominal. 4.- Planeamiento motor: inconsistente, solo logra movimientos simples. Skipping: no logrado, dificultades en planificación por hemisferio. Jumping Jacks: no logrado, no sincroniza.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: logrado. 1.2.-Se quita elementos sin ver: No logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: inconsistente. 2.2.-Copia 3D: no logrado 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: logrado -EE.II: Inconsistente. -Combinado: No logrado. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: pinzas con menor fuerza 3.1.-Dificultades oro-faciales: no observado. 3.2.-Orden de su espacio: no logrado.

Test de selectividad alimentaria en niños. Psicoeduka.

Dimensión evaluada	Observación
Repertorio alimentario	Entre 10 a 20 cantidad de alimentos.
Rechazo de grupos alimenticios	No acepta frutas, ni verduras, proteínas ni grasas saludables.
Reacciones sensoriales	Principalmente en alimentos mezclados y texturas pegajosas a veces.
Conductas asociadas	Conducta desadaptativa, dice frases como "me da asco", hace arcadas, rabieta.
Impacto funcional en rutina	No interfiere en su rutina familiar, tampoco en los eventos sociales.
Distractores al comer	La mayoría de las veces requiere de pantallas para comer
Alimentación en contexto familiar	No se logra pesquisar si es que almuerza en familia.

3. Valoración Cualitativa

3.1.- Algoritmo ADOS2

3.1.1. Comunicación

Narración de sucesos: Se observa que Emiliano presenta dificultades para narrar situaciones de contexto social que involucren a otras personas y mantengan coherencia relacional en el relato. Su discurso tiende a centrarse en elementos aislados, con limitada integración de perspectivas sociales.

Gestos y expresiones faciales: Presenta gestos y expresiones faciales principalmente cuando la interacción es intencionada y ocurre en contexto familiar. En situaciones de interacción social espontánea no se observan gestos descriptivos ni expresiones faciales que acompañen o complementen el contenido comunicativo.

Conversación social: No se cuenta con registro formal de conversaciones sociales recíprocas. Su participación comunicativa se caracteriza principalmente por responder a preguntas o intervenciones, más que por iniciar o sostener intercambios conversacionales de manera autónoma.

3.1.2. Interacción social recíproca

Contacto visual inusual: Presenta contacto visual poco sostenido en el tiempo. Requiere mediación para focalizar la mirada, especialmente cuando las actividades no son de su interés. El contacto visual mejora cuando la actividad se relaciona con sus temas de preferencia.

Expresiones faciales dirigidas a otros: Dirige expresiones faciales hacia otros principalmente como respuesta a temas de interés o en interacción con familiares cercanos.

Disfrute compartido durante la interacción: Manifiesta disfrute en actividades vinculadas a sus intereses específicos; sin embargo, no se observa disfrute social compartido con las evaluadoras cuando las actividades corresponden a contextos sociales comunes.

Iniciaciones sociales: Se observan escasas iniciaciones sociales espontáneas. Tiende a participar cuando es convocado, más que a iniciar interacciones por iniciativa propia.

3.1.3. Comportamientos restringidos y repetitivos

Se evidencia tendencia a fijarse en objetos o situaciones específicas, con dificultad para flexibilizar la atención o modificar la actividad propuesta.

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases: Se observa presencia ocasional de expresiones idiosincrásicas.

Manierismos motores: Se registran manierismos de manos y dedos en situaciones de evaluación.

Intereses sensoriales inusuales: No se observaron intereses sensoriales inusuales durante la evaluación.

3.2.- Análisis perfil sensorial

Según lo pesquisado en las evaluaciones SPM Hogar, test de selectividad y en la observación estructurada del procesamiento sensorial, se destaca principalmente que Emiliano presenta una hipersensibilidad oral, donde rechaza ciertos olores y texturas de alimentos importantes para su desarrollo, como lo son las frutas, verduras, proteínas y grasas saludables impactando en su conducta. Por otro lado, se observan dificultades a nivel de equilibrio, coordinación y planificación de movimientos, existiendo desafíos en la organización y control postural, planificación motora y secuenciación de movimientos.

Sistema sensorial	Tipo de respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporrespuesta, dificultad para la modulación vestibular	-Desafíos en coordinación ocular -Desafíos en actividades de la vida diaria -Desafíos en la atención -Desafíos en permanencia de actividades -Desafíos en conducta -Desafíos en la interacción social
Propioceptivo	Hiporrespuesta, dificultad para la modulación propioceptiva	-Desafíos en la estabilidad articular -Desafíos en control de postura Desafíos en planificación de movimientos -Desafíos en sincronización y disociación de por hemisferio -Torpeza motora -Baja conciencia corporal sin apoyo visual -Desafíos en atención -Desafíos en conducta.
Táctil	Hiporrespuesta, dificultad en modulación táctil	-Desafíos en discriminación táctil -Dificultad para calibrar fuerza -Dificultad para encontrar objetos sin apoyo visual -Prefiere mirar antes que hacer -Desafíos en copia -Desafíos para escritura y uso de tijeras.
Gusto y olfato	Hiperrespuesta	-Desafíos en alimentación -Desafíos en conducta -Rechazar alimentos por olor o sabor -Desafíos en interacción social

3.3.- Aparición de los síntomas y deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento.

En entrevista con los padres se analizan las principales dificultades en la crianza, las cuales se relacionan con los desafíos asociados al diagnóstico. Esto representa indicadores claros de síntomas vinculados a pataletas, dificultades en la flexibilización y desafíos predominantemente conductuales.

VI.- Síntesis del proceso

Considerando los antecedentes aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación interdisciplinario, los resultados de los instrumentos aplicados y los criterios diagnósticos establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), es posible señalar que **Emiliano** presenta alteraciones en las habilidades de comunicación, en la interacción social recíproca y en la flexibilidad mental, características compatibles con un trastorno del neurodesarrollo correspondiente a un **Trastorno del Espectro Autista (TEA)**.

El nivel de severidad, de acuerdo con la valoración cuantitativa obtenida mediante el ADOS-2, se sitúa en un rango **leve moderado**. En función de ello, y considerando el nivel de afectación según los criterios del DSM-5, requerirá **sopORTE de grado 2** tanto en el área de **intereses restringidos y conductas repetitivas**, como en el área de **comunicación social**.

En lo que respecta a la evaluación psicológica, es posible determinar que Emiliano presenta un funcionamiento cognitivo, conductual y emocional caracterizado por rigidez o patrones restringidos, sobre todo en lo que conlleva al juego o área de interés. Dentro de la evaluación, fue posible pesquisar de conductas desafiantes las cuales surgían ante la introducción a demandas o cuando se le establecían límites, conllevando a que la conducta interfiera en la participación de tareas estructuradas. Asimismo, es posible dar cuenta, a nivel emocional, de baja tolerancia a la frustración e impulsividad.

Cabe señalar que la presente conclusión corresponde a una **impresión diagnóstica**, construida a partir del momento actual de evaluación y de los antecedentes disponibles a la fecha. En este sentido, **no constituye un diagnóstico definitivo ni determina la proyección futura del Emiliano** dado el carácter dinámico del desarrollo y la influencia de múltiples factores contextuales, educativos y terapéuticos.

El resultado obtenido debe ser considerado como un insumo clínico relevante para la **toma de decisiones respecto de los pasos a seguir**, la planificación de apoyos y la orientación de intervenciones adecuadas a sus necesidades actuales, **sin que ello implique una limitación de sus potencialidades ni de su desarrollo integral**.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

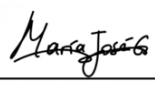
- Se sugiere la incorporación a Programa de Atención Temprana PAT, para el abordaje interdisciplinario con un enfoque de integración sensorial y potenciación de la comunicación.



Yara Vidal Velozo
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 654679
GRUPO PSICOEDUKA



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



María José Gajardo Tello
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Reg. SIS: 847842
GRUPO PSICOEDUKA



Valeria Ananías Gómez
Educadora Diferencial
Mg. en Desarrollo Cognitivo
GRUPO PSICOEDUKA